

UTKAST

Legala förutsättningar – nationellt högkostnadsskydd

Bakgrund till uppdraget

Inera har anlitat Guldager Consensus juristbyrå, jurist Bengt Guldager, för att genomföra en juridisk utredning vars avsikt är att fastställa under vilket/vilka lagrum som informationen ska hanteras som omfattas av den Nationella Tjänsten Högkostnadsskydd.

Utredningens närmare avgränsning och fokus presenteras senare.

Övergripande önskemål

Inera och regionerna har ett antal samstämmiga önskemål om vad som bör gälla i framtiden för högkostnadsskydd i öppenvård. Dessa önskemål kommer till uttryck i Ineras dokument ”Projektdirektiv Högkostnadsskydd”. I projektdirektiven anges bland annat följande.

Effektmålen är att bidra till effektiviserad hantering av efrikort för landstingens utomlänspatienter genom att digitalisera informationsdelningen mellan huvudmännen, samt att ge patienten möjlighet att hålla sig informerad om sin frikortsstatus vid utomlänsbesök och efter byte av mantalslän (flytt).

Efter att ha reflekterat över detta effektmål och de övriga upplysningar som ges på Ineras hemsidor för projektet samt i beslutsunderlag och förstudie med avseende på projektet tar undertecknad jurist sig friheten att något bryta ned vad som framkommer samt omformulera önskemålen enligt följande.

Regionerna och Inera önskar att för hantering av uppgifter om avgifter och avgiftsbefrielse för öppen vård:

- övergå från en manuell till en digital hantering

Kommentar: Detta är ett pågående arbete i många regioner men det är uppenbart att hanteringen i betydande omfattning kommer att digitaliseras om projektet genomförs och att detta också är något som önskas.

- övergå från regional till nationell hantering

Kommentar: När en patients rätt till avgiftsbefrielse beräknas tas redan idag viss hänsyn till avgifter som patienten har betalat i en annan region än patientens hemregion. Dessa processer tycks dock inte vara färdigutvecklade och de tycks därtill vara i det närmaste helt beroende av patientens aktivitet.

- övergå till att tillgängliggöra information till patienten digitalt

Kommentar: Redan idag informeras patienten på olika sätt om betalda avgifter och om avgiftsbefrielse. Uppenbart är dock att det finns en önskan om att patienten ska få mer korrekta och tydliga uppgifter men också en förbättrad tillgång till dessa.

Högekostnadsskydd för öppenvård

Centralt för denna utredning är det i föregående avsnitt redovisade önskemålen vilka alla gäller hantering av avgifter och högekostnadsskydd inom den öppna hälso- och sjukvården. Det kan därför vara lämpligt att redan tidigt i utredningen redogöra för den bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen som beskriver regionernas skyldigheter i detta avseende.¹

HSL 17 kap. 6 §

För den enskilde får följande poster tillsammans under ett år, räknat från det första tillfälle då avgift betalats, uppgå till högst 0,025 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, eller det lägre belopp som bestämts av regionen:

1. vårdavgifter som avser öppen vård enligt denna lag i andra fall än som avses i 8 § första stycket 1,
2. avgifter för förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §, och
3. avgifter för tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125).

Vid beräkning av avgiftsbefrielse enligt första stycket ska även sådana avdrag som har gjorts enligt 7 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medräknas.

Den enskilde patienten skyddas i svensk rätt på olika sätt från att drabbas av alltför höga kostnader. I HSL 17 kap. 6 § finns ett högekostnadsskydd för enskilda patienter och i den följande 7 § finns ett utvidgat skydd som på visst sätt gäller för samtliga barn i en familj. Patienten ska under ett års tid aldrig behöva betala mer än den maximala avgift som framgår

¹ Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ("HSL")

av bestämmelsen.² För närvarande, år 2020, är det maximala högkostnadsskyddet enligt bestämmelsen 1 150 SEK. När väl patienten har betalt avgifter upp till detta belopp är patienten befriad från ytterligare avgifter under resten av året räknat från det första avgiftstillfället.³

Av den av lagstiftaren valda strukturen i HSL framgår i vilka avseenden lagstiftningen riktar sig till regioner i deras roll som vårdgivare och i vilka avseenden lagstiftningen riktar sig specifikt till regioner i deras roll som sjukvårdshuvudman. Av HSL 1 kap. 1 § framgår att lagen gäller för samtliga vårdgivare samt för regioner och kommuner såsom sjukvårdshuvudmän. Av bestämmelsen framgår vidare att det finns fem avdelningar i HSL varav vissa gäller för all hälso- och sjukvård medan andra gäller specifikt för sjukvårdshuvudmännen. Av bestämmelsen framgår slutligen att de tredje och femte avdelningarna, specifikt innehåller bestämmelser som gäller huvudmännens ansvar. Lagbestämmelser om vårdavgifter och högkostnad regleras i lagens femte avdelningen, kapitel 17. Regionens ansvar i dessa frågor gäller således regionen i sin roll som sjukvårdshuvudman.

Fram till 1991 hanterades avgifter och högkostnadsskyddet av staten. Därefter överfördes avgiftshanteringen till landstingen med motiveringen att det skulle öka landstingens möjlighet till en effektivare styrning och förbättrad resursallokering.⁴ I förarbetena till den tidigare motsvarande lagbestämmelsen uttalades följande.⁵

Kommittén har tolkat uppdraget så att det är högkostnadsskyddet som skall vara statligt reglerat. När det gäller hälso- och sjukvård är huvudregeln att sjukvårdshuvudmännen själva fastställer patientavgifterna i öppen vård.

...

Detta innebär, som vi ser det, att den statliga regleringen endast bör avse sådant som motiveras av krav på likabehandling.

I dessa äldre förarbeten liksom i de nyare saknas redogörelser för hur landstingen/regionerna ska hantera avgifter och avgiftsbefrielse för patient som får sin vård i flera olika landsting/regioner. Många intressanta frågeställningar kan i detta avseende uppstå, men dessa behandlas överhuvudtaget inte. Av förarbetena att döma verkar det snarast som om patienterna alltid får sin vård i hemlandstinget/hemregionen. Hanteringen av de utmaningar som kan uppkomma vid gränsöverskridande vård tycks därmed lagstiftaren i huvudsak ha överlämnat till regionerna.

I dagens lagstiftning, ovan HSL 17 kap. 6 §, finns alltså kvar en otydlighet i frågan om högkostnadsskyddet ska anses vara nationellt eller regionalt. Bestämmelsen beskriver ett skydd för ”den enskilde”. Den enskilde individen ska aldrig behöva betala mer än den i bestämmelsen angivna högkostnaden. Detta i sig kan ses som ett uttryck för att högkostnaden

² Motsvarande gäller för förälder/föräldrar. Fortsatt i denna utredning kommer för enkelhets skull fokus ligga på kapitlets 6 §. I Ineras och regionernas fortsatta arbetet måste dock hänsyn tas till hantering som är nödvändig enligt 7 §.

³ I redogörelsen beskrivs de centrala delarna av bestämmelsen. Regionerna och Inera måste i sitt fortsatta arbete även beakta övriga delar såsom att regioner kan ha olika bestämmelser i fråga om den sista avgiftsbetalningen innan högkostnadsskyddet träder in.

⁴ För en allmän bakgrund till bestämmelsen se SOU 1995:122 *Reform på recept*, samt prop. 1996/97:27 *Läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m.*

⁵ SOU 1995:122 *Reform på recept* s.181-182

är ett absolut avgiftstak för de avgifter/avdrag som regleras i bestämmelsen. Med detta synsätt borde skyddet vara detsamma för varje enskild individ oavsett var i landet denne är bosatt eller var denne får sin vård. Samtidigt anges i bestämmelsen att ”regionen” har möjlighet att för sin egen del bestämma ett lägre högstkostnadsbelopp än vad som framgår av lagbestämmelsen. Ingen nationell likabehandling för patienterna i den delen alltså. Den statliga/nationella likabehandlingen som förespråkas i ovan citerat uttalande tycks därmed redan enligt lagbestämmelsen vara något som inte är tänkt att väga särskilt tungt.

Med ovan beskrivna motsägelser i lagstiftningen är det föga förvånande att de olika regionerna har valt delvis olika sätt att tillämpa lagstiftningen. I en del regioner är det hemregionens högstkostnadsnivå som gäller för alla som får vård i regionen, medan andra regioner har utgått från att hemregionens högstkostnadsnivå endast gäller för de som är bosatta i regionen. Flerparten regioner tillämpar det legala maximala högstkostnadsskyddet 1150 SEK. Några regioner har dock nyttjat möjligheten som ges i lagbestämmelsen och fastställt en lägre nivå, 1100 SEK.⁶

Idag sker merparten av regionernas bevakning av högstkostnadsskyddets korrekta tillämpning manuellt. Ett pappershäfte delas ut till patienter i vilket det införs en stämpel när patienten har betalt. När patienten uppnår avgiftsbefrielse skrivs ett s.k. frikort ut. Under den på frikortet angivna avgiftsbefriade tidsperioden får patienten vård utan avgift mot uppvisande av frikortet. Denna hantering är förutom att vara extremt otidsenlig även i flera avseenden högstgradigt osäker. Regionerna saknar i stora delar den kontroll över betalda avgifter och fastställd avgiftsbefrielse som gällande rätt föreskriver. Hanteringen uppvisar därmed stora brister i regionernas möjlighet att leva upp till sitt lagreglerade ansvar.

Sammanfattningsvis i denna del kan för den fortsatta utredningen konstateras att avgifter och avgiftsbegränsningar är frågor som regioner hanterar i sin roll som sjukvårdshuvudman och således inte i sin roll som vårdgivare. Vidare kan konstateras att trots ovan beskrivna motsägelser ger bestämmelserna i HSL sammantaget ett tydligt uttryck för att regionerna har ett ansvar för att hantera avgifter för patienter oavsett var i landet dessa är bosatta och likaså ett tydligt delat ansvar för att hantera högstkostnadsskyddet för samtliga patienter – i korthet ett tydligt nationellt ansvar.

Avgränsning och fokus

Med utgångspunkt i den centrala lagbestämmelsen HSL 17 kap. 6 § kommer i detta avsnitt redogöras för den närmare avgränsningen av föreliggande utredning.

Inera och regionerna har under en tid arbetat med ”Projekt Högstkostnadsskydd”. Under arbetets gång har framkommit att olika aktörer har delvis olika uppfattning om hur den rättsliga

⁶ Uppgifterna hämtade från Ineras ”Beslutsunderlag - nationell e-tjänst för högstkostnadsskydd och frikort 1,0” samt från SKR:s ”Patientavgifter 2020” på https://skr.se/download/18.39f6c30c16fa49d62c532a6b/1579263933840/avgifter_%C3%B6ppen_slutenvard_2020.pdf

grunden för projektarbetet ska beskrivas. Ineras programråd har utsett en samverkansgrupp vars uppdrag är att ena samtliga regioner.

Undertecknad jurist har mot denna bakgrund av Inera såsom externt anlitad aktör fått uppdraget att genomföra en juridisk utredning i avsikt att fastställa under vilket/vilka lagrum som informationen ska hanteras som omfattas av den Nationella Tjänsten Högkostnadsskydd. När uppdraget tilldelades betonades av Ineras medarbetare att utredningen i allt ska vara opartisk.

Det finns i gällande rätt flera olika slags högkostnadsskydd med anknytning till hälso- och sjukvården. Nu aktuell utredning avser endast frågor som rör det specifika högkostnadsskydd som gäller för avgifter i öppenvården och som regleras i HSL 17 kap. 6-7§§. Av 6 § framgår vilka avgifter som ingår vid beräkningen av högkostnadsskyddet enligt bestämmelsen. De avgifter/avdrag som ska inräknas är:

- vårdavgifter för öppen hälso- och sjukvård
- avgifter för vissa förbrukningsartiklar ⁷
- avgifter för viss tandvård ⁸
- avdrag som har gjorts vid bestämmande av ersättningens storlek för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ⁹

Utredningen har sitt särskilda fokus på den ovan första strecksatsen, ”vårdavgifter för öppen hälso- och sjukvård”, men utredningens bedömningar och ställningstaganden är tillämplbara på samtliga avgifter/avdrag i ovan strecksatser.

De analyser som görs och lagrum som belyses i utredningen syftar alla till att klargöra de avgörande rättsliga moment utifrån vilka det är möjligt att ta ställning till vilket eller vilka lagrum som enligt utredande jurists uppfattning bör utgöra grund för informationshanteringen i en nationell tjänst för högkostnadsskydd. Utredningen gör därmed inte anspråk på att fungera som någon allmän kartläggning av rättsområdet.

De underlag som översänts inför utredningsstarten beskriver i stora delar praktiska och tekniska aspekter med avseende på den Nationella Tjänsten Högkostnadsskydd. Med anledning härav erinras om begränsningen att denna utredning enbart avser juridiska ställningstaganden.

En juridisk utredning med avseende på en nationell tjänst för hantering av högkostnadsskydd kan ge upphov till en mängd frågeställningar inom ett antal olika rättsområden. Denna utredning fokuserar på rättsregler som avser sådan digital informationshantering och informationsdelning som en nationell tjänst för högkostnadsskydd ger upphov till. Bland annat

⁷ Sådana som avses i HSL 8 kap. 9 §

⁸ Sådana som avses i tandvårdslagen (1985:125) 8 a §

⁹ Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 7 § andra stycke. Av bestämmelsen framgår att avdrag ska göras med ett belopp som motsvarar de avgifter som patienten skulle ha betalt för vården i Sverige.

följande rättsfrågor behandlas därför som utgångspunkt inte i denna utredning; konkurrensrättsliga, upphandlingsrättsliga, kommunalrättsliga och avtalsrättsliga.

Uppgifter som registreras

För att kunna analysera vilka rättsregler som blir tillämpliga när regionernas önskemål om ett nationellt elektroniskt högkostnadsskydd ska uppfyllas måste först klargöras vilka specifika uppgifter som måste registreras. Redan utifrån den centrala bestämmelsen om högkostnadsskydd i öppenvård, HSL 17 kap. 6 §, kan konstateras att i vart fall följande uppgifter måste ingå i den hantering som är föremål för aktuell utredning:

- a) Uppgift om patientens identitet
- b) Uppgift om avgift som patienten har betalt med tidpunkt för betalning
- c) Uppgift om avgiftsbefrielse med information om tidsperiod för avgiftsbefrielse

Vid en betraktelse av den information som regionerna tillhandahåller på olika hemsidor och via www.1177.se kan konstateras att flertalet regioner hanterar flera och delvis andra uppgifter i sitt arbete med högkostnadsskydd för öppenvård. Ett av flera exempel är uppgift om debiterad och ännu inte betald avgift. Med respekt för att denna och andra uppgifter kan vara intressanta ur ett antal perspektiv är de inte av avgörande betydelse för den aktuella juridiska analysen. Vissa sådana övriga uppgifter kommer dock i någon mån att avhandlas och kommenteras i lämpligt sammanhang i den fortsatta utredningen.

Med utgångspunkt från den centrala bestämmelsen i HSL 17 kap. 6 § är de ovan uppräknade uppgifterna de enda som är helt nödvändiga för en korrekt tillämpning av bestämmelsen. Man kan därmed se uppräknade a), b) och c) som en minimalistisk utgångspunkt för den nu aktuella utredningen.

Här ska nu först helt kort respektive punkt a) – c) kommenteras:

a) Uppgift om patientens identitet

Här är det i normalfallet uppgifter om patients personnummer eller samordningsnummer som avses. I folkbokföringslagen finns bestämmelser om personnummer och samordningsnummer.¹⁰ Personnummer används för fysiska personer som är folkbokförda. För övriga kan tilldelas ett samordningsnummer efter begäran av behöriga myndigheter och organ. Det är Skatteverket som hanterar personnummer och samordningsnummer. Det finns ett antal olika tänkbara situationer där patienter varken har person- eller samordningsnummer. Olika regioner hanterar dessa på delvis olika sätt. För nu aktuell utredning kan konstateras att ett nationellt högkostnadsskydd förutsätter att patienten kan identifieras på ett mer permanent sätt och att det måste vara fråga om uppgifter som är desamma i hela landet. Mot denna bakgrund

¹⁰ Se folkbokföringslagen (SFS 1991:481), fr.a. lagens 18-18b §§

är det endast person- och samordningsnummer som bör användas vid en nationell högkostnad.

b) Uppgift om avgift som patienten har betalt med tidpunkt för betalning

Av HSL 17 kap. 6 § framgår tydligt att förutsättningen för avgiftsbefrielse är att det är fråga om avgifter som har "betalats" av patienten. Varken tidigare gällande motsvarande lagstiftning om högkostnadsskydd eller förarbetsuttalanden till nuvarande eller tidigare lagstiftning motsäger detta, utan bekräftar snarast att det ska vara fråga om avgifter som har betalats/erlagts. I förarbeten till den tidigare motsvarande bestämmelsen uttalades följande.¹¹

Ett viktigt syfte med att ha ett högkostnadsskydd, ett syfte som framgår av förarbetena har varit att hjälpa patienter med betalningssvårigheter och att se till så att dessa inte drabbas av temporära likviditetsproblem.

Enligt bestämmelsen ska således uppgift om fakturerade, ännu obetalda, avgifter inte utgöra grund för avgiftsbefrielse. Om någon region trots detta väljer att inkludera icke-betalda avgifter vid beräkning av avgiftsbefrielse behöver denna region, utöver a) - c) göra ett tillägg för uppgift om tidpunkt för när avgift har debiterats. Som framgår av det sagda har dock lagstiftaren inte avsett att det ska gå till på det sättet. En sådan hantering innebär istället sannolikt att regionen utan sakligt godtagbara skäl i avgiftshänseende hanterar sina patienter olika.¹²

c) Uppgift om avgiftsbefrielse med information om tidsperiod för avgiftsbefrielse

Detta är den viktigaste informationen sett ur perspektivet lagstiftningens syfte. Avgiftsbefrielsen är själva essensen med bestämmelsen om högkostnadsskydd. Om patienten betalar avgifter utan att få den avgiftsbefrielse som patienten har rätt till innebär det att regionerna har agerat i strid med HSL 17 kap. 6 §.

Alldeles oavsett regionernas ambitionsnivå är det omöjligt att helt undvika att en uppgift om avgiftsbefrielse i efterhand kan visa sig vara felaktig. Detsamma gäller för uppgift om betalda avgifter. Det kommer därför alltid att finnas situationer när uppgifterna på olika sätt måste korrigeras. Ett fullständigt automatiserat förfarande är i denna del svår att tänka sig om målsättningen är en korrekt tillämpning av lagstiftningen med ett korrekt agerande i avgiftshänseende gentemot patienterna. Det kommer därför att behöva göras manuella korrigeringar av uppgifter, s.k. efterregistreringar.

Efterregistrering av uppgifter

Av det anförda framgår att det även vid användning av en nationell tjänst kommer uppkomma situationer där uppgifter behöver registreras i efterhand. Först i denna fråga måste påminnas om det nyss sagda, att lagregleringen om högkostnadsskydd utgår från faktiskt

¹¹ SOU 1995:122 Reform på recept s.175-176

¹² Det kan strida mot kraven på likabehandling i HSL och mot den s.k. likställighetsprincipen i kommunallagen (2017:725) 2 kap. 3 §

betalda avgifter. I denna utredning kommer därför inte efterregistreringar relaterat till debiterade avgifter att avhandlas.

Ibland behöver efterregistreringar göras i närtid. En patient som har lämnat ifrån sig kontanter kan tvingas vänta en kortare stund medan personalen byter kassarulle för att möjliggöra utskrift av kvitto. Ett annat exempel är att personalen plötsligt blir tvungen att akut omhänderta en annan patient. I situationen kommer patienten vanligen, efter en kortare tid, få sin betalade avgift registrerad. Vid dessa exempel görs efterregistreringar normalt sett på samma plats och av samma person som först mottog kontanter från patienten. Denna slags efterregistreringar innebär inga särskilda svårigheter eftersom efterregistreringen görs på samma sätt som en omedelbar registrering.

Det finns dock situationer när efterregistreringen kan komma att behöva ske långt senare. Ett exempel på detta kan vara att någon för uppgiften behörig person tar emot kontanter från en patient. Mottagaren väljer att inte på ett korrekt sätt registrera att avgiften har betalats utan behåller istället mottagna kontanter för sin egen del. I exemplet begås alltså ett förmögensbrott av mottagaren. Varianter på olika slags brottsliga eller på annat sätt oegentliga eller grovt vårdslösa situationer kan tänkas. När denna typ av situationer uppmärksammas så måste det ske en efterregistrering. Efterregistreringen görs då oftast av någon helt annan person än den som mottog kontanterna. Det kan vidare ta lång tid, ibland flera år, från tidpunkten när registrering borde ha gjorts tills efterregistrering sker. Särskilt lång tid tar det när det måste till en prövning i domstol för att klargöra vad som har inträffat.

Man kan även tänka sig den motsatta situationen att en registrering sker fastän patienten aldrig har betalt något. Det kan röra sig om ett tekniskt systemfel eller rena misstagsregistreringar. Regionen kan då teoretiskt behöva rikta återkrav mot patienten. I vilken utsträckning detta förekommer är oklart, men det bör vara ytterst sällsynt. Innan så sker måste regionen beakta att det är regionen – och inte patienten – som är ansvarig för patientens högkostnad enligt lag och som också ansvarar för att endast nödvändiga och korrekta uppgifter registreras. När uppgifter av misstag registreras på fel patient påverkas dessutom högkostnadsberäkningen för flera patienter. Den patient som faktiskt har betalt måste få uppgiften efterregistrerad med koppling till sin person.

Ytterligare situation som kan inträffa är att fel avgiftsnivå registreras. När detta uppmärksammas så måste detta rättas till. Är situationen den att patienten har betalt för lite så måste även i detta fall regionen, innan krav riktas mot patienten, beakta att det som utgångspunkt inte är patienten som har felat. Regionen ansvarar för hanteringen och också för den information om avgifter som ges till patienten. Att patienten har betalt för lite kan dock ha många olika orsaker varför det även finns situationer där det är högst rimligt att krav riktas mot patienten. Har patienten betalt för mycket måste också detta korrigeras i efterhand.

Regionens ansvarar som sagt enligt HSL för frågor som rör högkostnadsskyddet. Själva arbetet kan utföras av någon annan på uppdrag av regionen. När regionen anlitar privata vårdgivare så måste regionen i avtalen med dessa reglera hur den privata aktören ska hantera vårdavgifter och patientens högkostnad. Regionen kan i avtalen i detalj föreskriva hur dessa ska arbeta och också hur och när uppgifter om avgifter och avgiftsbefrielse ska överföras till regionen.

Överföringen av uppgifter från vårdgivare med vilka regionen har en avtalsrelation kan ske mer eller mindre direkt vid registreringen. För vissa avtalsrelationer kan det finnas ett längre tidsglapp mellan registrering av den privata vårdgivaren till dess registreringen blir synlig eller tillgänglig för den ansvariga regionen. Regionen kan dock genom kravställande i avtalen själv avgöra hur långt tidsglapp som ska finnas.

Det finns privata vårdgivare vars uppdrag inte styrs av regionerna genom avtal, utan av särskild lagstiftning, tidigare ofta kallad taxelagstiftning.¹³ Regionerna kan för dessa verksamheter inte styra hur och när dessa redovisar uppgifter om avgifter och avgiftsbefrielse. I taxelagstiftningen finns bestämmelser om vårdavgifter och högstkostnadsskydd liknande de som finns för regionerna i HSL kapitel 17.¹⁴ Regionen är dock som sjukvårdshuvudman enligt HSL 7 kap. 2 § andra stycke övergripande ansvarig även för nu aktuell vård.¹⁵ Av taxelagstiftningen med tillhörande förordningar framgår att vårdgivaren måste tillhandahålla regionen uppgifter om avgifter och om högstkostnadsskydd.¹⁶ Dessa sistnämnda bestämmelser är ospecifika i vad gäller när i tiden verksamhetsutövaren ska redovisa dessa uppgifter för regionen. Regionen kommer därför, så länge som taxelagstiftningen består i sin nuvarande form, att behöva efterregistrera uppgifter från dessa verksamheter.

Patienterna är inte sällan de som bäst har överblick i frågan om vilka avgifter de har betalt och när de uppnår högstkostnaden. Om regionen eller en vårdgivare hävdar något som patienten anser vara felaktigt måste ibland patienten vända sig till den som har huvudansvar, dvs regionen. Det finns då ofta behov att närmare gå igenom avgifter som har betalats under en längre tid och också avgifter som har betalats till flera olika vårdgivare. En av regionens anställda kan ha agerat felaktigt, en privat vårdgivare likaså. Anställda kan ha slutat och privata vårdgivare kan till och med ha upphört att existera. Det yttersta ansvaret för registreringar är dock alltid regionens. Regionen kan gentemot patienten inte fransäga sig sitt lagstadgade ansvar under åberopande av att någon av regionen anställd person eller anlita aktör på ett eller annat sätt har brustit.

Vid flera av de ovan uppräknade situationerna registreras uppgifter om avgift och högstkostnad av anställda i regionens centrala administration. En vårdgivare eller vårdenhets som helt saknar koppling till de vårdavgifter och till de patienter som efterregistreringarna avser kan inte gärna ges i uppgift att registrera dessa uppgifter.

Regionens legala skyldigheter i vad gäller efterregistreringar har i detta avsnitt utretts relativt noggrant. Detta har gjorts för att tydliggöra att ingen vårdgivare kan ansvara för detta arbete, varken ur ett praktiskt eller ett legalt perspektiv. Sammanfattningsvis i detta avsnitt kan konstateras att gällande rätt innebär att regioner i sin roll och i sitt ansvar som sjukvårdshuvudman måste utföra efterregistreringar.

¹³ Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, samt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

¹⁴ Lag om läkarvårdsersättning 22-25a §§, samt lag om ersättning för fysioterapi 22-24a §§

¹⁵ Att det är denna ordning som är avsedd, dvs att det är den aktör som fastställer högstkostnadsskyddet och inte vårdgivarna med verksamhet enligt lag som ansvarar för att bevaka högstkostnaden, framgår även av lagförarbeten från tiden när staten var huvudman med ansvar för högstkostnadsskydd i öppenvård, se upphävd lag (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. 7 §.

¹⁶ Se not 12, samt förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning 14, 18 §§, samt förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi 14, 17 §§

Betraktelser relaterat till av Inera tidigare genomförd rättsutredning

Hitintills har utredningen fokuserat på gällande rätts krav på regionerna att tillse att HSL:s bestämmelser om högkostnadsskydd tillämpas på ett korrekt sätt. Som framgår av ovan avsnitt "Övergripande önskemål" är regionerna och Inera gemensamt av uppfattningen att uppgifter om högkostnadsskyddet framgent så långt möjligt ska hanteras digitalt.

Inera har låtit sin jurist Manólis Nymark utreda rättsliga förutsättningar för en nationell högkostnadsskyddstjänst.¹⁷ Utredande jurist har tagit del av denna utomordentligt väl genomförda och i många avseenden ytterst detaljerade utredning. Ineras jurist har i sin utredning tagit avstamp i den s.k. registerlagstiftningen.¹⁸ PUL har numera ersatts av EU:s dataskyddsförordning¹⁹ samt dataskyddslagen.²⁰ Den nya lagstiftningen har inte inneburit något av avgörande betydelse för de bedömningar som görs i nu aktuell utredning.

Nu utredande jurist instämmer till del i vad som anförs i Ineras rättsutredning.²¹ Utredande jurist delar bland annat uppfattningen att de uppgifter om högkostnadsskydd som hanteras och som avses hanteras digitalt:

- är personuppgifter²²
- är känsliga personuppgifter om hälsa²³
- är sådana att PDL:s bestämmelser ska tillämpas²⁴
- är uppgifter som får registreras utan patientens samtycke²⁵

De uppgifter som uppräknas i nu aktuell utrednings avsnitt "Uppgifter som registreras", och eventuella ytterligare uppgifter som regionerna anser är nödvändiga för arbetet med högkostnadsskyddet, är uppgifter som på ett eller annat sätt har sitt ursprung från en situation när en patient har fått vård. Omvänt kan sägas att om ingen vård har tillhandahållits finns heller ingen anledning att registrera uppgifter om betald patientavgift. Nu utredande jurist delar därmed den i Ineras rättsutredning framförda uppfattningen att den initiala registrering som i ett senare skede ligger till grund för regionens krav på patientavgift är en registrering som görs i en vårdgivarares vårddokumentation. Med detta som utgångspunkt landar Ineras rättsutredning i den preliminära bedömningen att "övervägande skäl talar för att personuppgiftsbehandlingen i den nationella tjänsten bör baseras på den juridiska modellen opt-out

¹⁷ Nationell tjänst för högkostnadsskyddets administration, RÄTTSPROMEMORIA 2015-10-14, ver 0.3

¹⁸ Personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL"), samt patientdatalagen (2008:355) ("PDL")

¹⁹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

²⁰ Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

²¹ Särskilt diskussioner om registerlagstiftningen i rättsutredningens avsnitt 4.2 och 4.3

²² EU:s dataskyddsförordning, art 7 punkt 1

²³ EU:s dataskyddsförordning, art 9.1 och 9.2 (h)

²⁴ PDL 1 kap. 1 § och 4 §

²⁵ PDL 2 kap. 2 §

som finner stöd i PDL:s bestämmelser om sammanhållen journalföring”. I Ineras rättsutredning förespråkas vidare att administreringen av högkostnadsskyddet ska ske med stöd av PDL 2 kap. 4 § första stycke punkt 2.

I frågan om vilken ändamålsbestämmelse i PDL som är tillämplig och i vad gäller uppfattningen att sammanhållen journalföring skulle vara möjlig – i de frågorna är nu utredande jurist av en annan/motsatt uppfattning, vilken uppfattning utvecklas i det följande.

Ändamål enligt PDL

Först får erinras om att PDL ska tillämpas vid behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Uppgifter om avgifter och avgiftsbefrielse är uppgifter som onekligen både härrör från och hanteras av hälso- och sjukvårdens olika vårdgivare. PDL är således tillämplig på hanteringen av uppgifter om vårdavgifter. Därefter blir frågan vilken ändamålsbestämmelse som det bör hänvisas till som stöd för behandling av uppgifter avseende högkostnadsskyddet.

PDL 2 kap. 4 § första stycke

Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för

1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter,
2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,
3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning,
4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten,
5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, eller
6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

Det ligger nära till hands att uppfatta att uppgifter om vårdavgifter är uppgifter om ”administration som rör patienter och som ... föranleds av vård i enskilda fall”. Initialt när uppgifter om den vård som tillhandahålls patienten registreras så görs detta med stöd av PDL 2 kap. 4 § första stycke punkt 2.²⁶ Flera av de uppräknade ändamålsbestämmelserna kan dock vara tillämpliga på behandling av en viss uppgift. Att en uppgift har sitt ursprung i vårddokumentationen hindrar inte att uppgiften behandlas med stöd av ett annat i lagbestämmelsen angivet ändamål.

Av intresse i frågan är lagstiftarens följande uttalande i förarbetena till PDL (prop. 2007/08:126 s.56-57).

²⁶ Det är därför inte överraskande att Datainspektionen anser att ändamålsbestämmelsen i punkt 2 torde kunna tillämpas för dessa registreringar enligt samrådsyttrande 2015-02-16, dnr 2688-2014.

Patientdatalagens ändamålsbestämmelser föreslås vara fakultativa i den bemärkelsen att de reglerar vad vårdgivare får göra. Syftet med ändamålsbestämningen är att ange en yttersta ram för när personuppgifter får samlas in och fortsättningsvis behandlas med stöd av patientdatalagen och personuppgiftslagen. En och samma behandling av personuppgifter kan ske för mer än ett ändamål. Särskilt gäller detta i sådana stora elektroniska informationssystem som integrerar en mängd olika funktioner.

Även följande uttalande är av intresse (prop. 2007/08:126 s.227).

Paragrafen har utförligt behandlats i avsnitt 7.1. I paragrafens första stycke anges de primära ändamålen, alltså sådana ändamål som tar sikte på den egentliga kärnverksamheten inom hälso- och sjukvården. De primära ändamålen beskriver personuppgiftsbehandlingar som normalt äger rum i varje sjukvårdshuvudmans verksamhet. De angivna ändamålen avser inte bara den individinriktade hälso- och sjukvårdsverksamheten utan också sådana särskilda ändamål som faller vid sidan av den individinriktade verksamheten.

Regionernas arbete enligt HSL med att hålla uppsikt över patienternas betalda avgifter och att meddela avgiftsbefrielse är ett arbete som i stora delar sker på en övergripande nivå. Detta arbete sker inte sällan på en annan plats än den plats där vården tillhandahålls. En för högkostnadsskyddets beräkning väsentlig uppgift är uppgiften att en avgift har betalats. Redan denna registrering om att avgift har betalats hanteras ofta av regionens övergripande ekonomistyrning. Som vanligt förekommande exempel kan nämnas situationen när patienten har valt att betala avgiften via faktura och betalningen inflyter via den centrala administrationen.

Detta regionernas arbete, med bland annat efterregistreringar såsom beskrivits i tidigare avsnitt, är till stora delar arbete som omöjligen kan utföras av någon annan än regionen. Det är vidare enligt HSL inte vårdgivaren som är ansvarig för att hantera högkostnaden, utan regionen såsom sjukvårdshuvudman. Regionens anställda i central ekonomisk administration hanterar också uppgifter från vårdgivare i andra regioner som avser betalda avgifter för utförd vård. Denna hantering uppvisar mycket stora likheter med den när desamma anställda hanterar uppgifter om ersättning för den vård som utförts i den andra regionen. Hanteringen av detta sistnämnda slag brukar motiveras med hänvisning till PDL 2 kap. 4 § första stycke punkt 5. Om denna punkt uttalades i förarbetena följande (prop. 2007/08:126 s.228-229).

Punkten 5 innebär att den personuppgiftsansvarige fortlöpande eller vid särskilda tillfällen kan administrera, planera, följa upp, utvärdera och utöva tillsyn av verksamheten på olika nivåer. Den administration och planering som avses här sker på ett mer övergripande plan än vad som avses med den patientadministration som omfattas av ändamålet vårddokumentation (punkterna 1 och 2). Punkten 5 gör det möjligt för hälso- och sjukvården att bedriva verksamhetsuppföljning med individuppgifter.

Regionernas hantering av uppgifter om avgifter och avgiftsbefrielse bör ske med stöd av denna bestämmelse, dvs PDL 2 kap. 4 § första stycke punkt 5. Man kan möjligen fundera över om bestämmelsens punkt 3 skulle kunna vara tillämplig. Den kan det hänvisas till vid hantering av personuppgifter som innebär att det upprättas annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning. Att registrera uppgifter om högkostnad enligt HSL

är otvetydigt en hantering som följer av lag. Möjligen kan ett register med uppgifter om högst kostnad anses vara sådan ”annan dokumentation” som avses i bestämmelsen. Alternativt kan möjligen besked om avgiftsbefrielse anses vara sådan ”annan dokumentation”. Det finns därmed flera tänkbara ändamålsbestämmelser att hänvisa till. Utredande jurist anser dock att punkt 5 är den i sammanhanget mest naturliga ändamålsbestämmelse till vilken regionerna bör hänvisa till i sitt arbete med högst kostnadsskydd.

Sammanfattningsvis upprepas utredande jurists uppfattning att i en nationell tjänst för högst kostnadsskydd bör uppgifter hanteras med stöd av PDL 2 kap. 4 § första stycke punkt 5.

Digitalt utlämnande av uppgifter

Som framgår av tidigare avsnitt kommer uppgift om betalda avgifter och om avgiftsbefrielse att behöva lämnas ut från en region till en annan region. En myndighet kan lämna ut uppgifter digitalt på två olika sätt.

Det ena sättet för digitalt utlämnande är genom s.k. direktåtkomst. Direktåtkomst innebär att mottagaren ges direkt tillgång till avsändarens databas eller register. Mottagaren kan på egen hand fritt söka efter information. Den myndighet som lämnar ut uppgifter har i detta fall inte någon kontroll över vilka uppgifter som mottagaren väljer att ta del av. Vid direktåtkomst fattar den utlämnande myndigheten sitt beslut om utlämnande redan när myndigheten beslutar att tekniskt möjliggöra för den andre myndigheten att få åtkomst till uppgifterna.

Det andra sättet för digitalt utlämnande är ”utlämnande på medium för automatiserad behandling”.²⁷ Med detta menas all annan form av digitalt utlämnande. Under informations-samhällets och digitaliseringens första tid avsågs fysiskt utlämnande av magnetband och sedermera disketter och än senare USB-stickor – dvs olika slags informationsbärare/medium på vilka fanns digitalt lagrad information. Numera sker utlämnandet vanligtvis genom överföring mellan datorer vilka sammankopplats genom ett kommunikationsnät av något slag. Formuleringen ”medium för automatiserad behandling” kan därför uppfattas som föråldrad, men det är den formulering som används än idag. Det som avses är dock som sagt allt digitalt utlämnande som inte är direktåtkomst.

Det som skiljer direktåtkomst från utlämnande på medium för automatiserad behandling är främst frånvaron av en kontrollfunktion. Den myndighet som genom direktåtkomst lämnar ut uppgifter prövar inte i samband med utlämnandet om en viss uppgift eller handling får lämnas ut och inte heller hur många uppgifter eller handlingar som får lämnas ut. Vid utlämnande på medium för automatiserad behandling har den aktör som lämnar ut information full kontroll över vad som lämnas ut.²⁸

²⁷ PDL 5 kap. 6 §

²⁸ Mer information om vad som utmärker ett utlämnande som inte utgör direktåtkomst finns i *Elektroniskt Informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektronisk form*.

Högsta förvaltningsdomstolen har tydliggjort skillnaden mellan utlämnande genom direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.²⁹ Avgörandet är prejudicerande och ger uttryck för gällande rätt.

I målet gavs socialnämnder via Försäkringskassans IT-stöd ”LEFI Online” möjlighet att få ut uppgifter ur Försäkringskassans socialförsäkringsdatabas. LEFI Online är en automatiserad tjänst, en fråga/svarstjänst med fördefinierade frågor och svar. LEFI Online kan nås via två olika gränssnitt, ett system-till-system och ett webb-baserat. Socialnämndens anställda skickar med avseende på en viss individ med visst personnummer en fråga om vilka förmåner eller ersättningar som individen har fått under en viss period. Socialnämndens anställda legitimerar sig via ett elektroniskt certifikat. Försäkringskassans IT-system kontrollerar certifikatet och att det i begäran endast efterfrågas sådan information som socialnämnden med hänsyn till sekretessregler har rätt till. Försäkringskassans IT-system sammanställer efterfrågad information och en svarsfil skickas till socialnämndens anställda.

Datainspektionen ansåg att Försäkringskassan genom det valda upplägget hade låtit socialnämnderna få direktåtkomst till uppgifterna och att detta stred mot lag.³⁰ Försäkringskassan ansåg för sin del att det överhuvudtaget inte var fråga om direktåtkomst. Enligt Försäkringskassan var det istället ett tillåtet utlämnande på medium för automatiserad behandling.

Underinstansen, förvaltningsrätten, ansåg för sin del att det för ett utlämnande på medium för automatiserad behandling krävs att det fattas ett beslut som baseras på en reell prövning i det enskilda fallet. Det var enligt förvaltningsrätten inte tillräckligt att det i IT-stödet fattades ett automatiserat beslut utifrån fördefinierade kriterier. Eftersom någon reell prövning inte gjordes inför utlämnandet så ansåg förvaltningsrätten att socialnämnden hade direktåtkomst till uppgifterna.

Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten som uttalade följande.

För att det ska vara fråga om ett utlämnande på medium för automatiserad behandling krävs antingen att det är fråga om en s.k. batch-körning, som utgörs av ett automatiskt utlämnande efter en sökning och sammanställning där svaret lämnas med viss tidsfördröjning, eller att utlämnandet baseras på en reell prövning i det enskilda fallet.

Eftersom det i LEFI Online varken gjordes någon batch-körning eller någon reell sekretessprövning med individuellt fattat beslut, så var det även enligt kammarrätten fråga om direktåtkomst.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde underinstansernas domar. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen skulle gränsdragningen mellan direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling göras med stöd av tryckfrihetsförordningens 2 kap. 6 § första stycke som lyder.³¹

²⁹ HFD 2015 ref. 61

³⁰ Datainspektionen hänvisade till socialförsäkringsbalken 114 kap. 22 §

³¹ I målet hänvisades till tryckfrihetsförordningens (1949:105) 2 kap. 3 § andra stycke. Ingen ändring i sak har skett utan endast ändringar som språkliga och redaktionella.

En upptagning som avses i 3 § anses förvarad hos en myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

Domstolen ansåg inte att socialnämnderna fick någon sådan teknisk tillgång som avses i bestämmelsen. Det mest centrala partiet i detta prejudicerande avgörande lyder.

Socialnämnderna kan inte på egen hand söka information i socialförsäkringsdatabasen, utan ett utlämnande genom LEFI Online förutsätter att Försäkringskassan reagerar på en begäran om att de efterfrågade uppgifterna ska lämnas ut. Försäkringskassan får därigenom anses förfoga över frågan om och i så fall vilka uppgifter som ska lämnas ut.

Av avgörandet framgår tydligt att högsta instansen inte delade underinstansernas bedömningar. Vid ett utlämnande på medium för automatiserad behandling krävs således inte någon batch-körning med tidsfördröjning, utan uppgifterna kan lämnas ut omedelbart. Det är därtill tillåtet att ha ett fullt ut systembaserat/automatiserat beslutsfattande. Det som Högsta förvaltningsdomstolen fäster avgörande vikt vid är att socialnämndens anställda inte har haft möjlighet att själva fritt söka i Försäkringskassans IT-system för att välja ut vilka uppgifter de anser sig behöva få tillgång till. En fråga-svarstjänst där svar levereras utifrån fördefinierade förutsättningar är således enligt gällande rätt ett utlämnande på medium för automatiserad behandling. En nationell tjänst för högkostnadsskydd bör ha goda förutsättningar att hantera uppgiftsutlämnandet på ett motsvarande sätt.

Direktåtkomst kräver uttryckligt stöd i lag. För hälso- och sjukvårdens del finns bestämmelser om direktåtkomst i PDL kapitel 6. Direktåtkomst kallas här för sammanhållen journalföring. Med detta åsyftas åtkomst till en annan vårdgivares journalsystem för ändamålen vård och behandling.³² Mottagaren av uppgifterna måste vara en vårdgivare som när denne bereder sig åtkomst har en aktuell patientrelation.³³ Alternativt kan åtkomst ske om uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten.³⁴ Inget av dessa alternativ är tillämpliga när som i detta fall en anställd hos en vårdgivare söker efter information hos en annan vårdgivare för att avgöra om en patient ska medges avgiftsbefrielse.

Sammanhållen journalföring är enligt PDL 6 kap. 1 § endast möjlig vid uppgiftshantering som sker med stöd av PDL 2 kap. 4 § första stycke punkt 1 och 2. Som framgår av föregående avsnitt anser utredande jurist att uppgiftshantering i en nationell tjänst för högkostnadsskydd inte bör ske med stöd av bestämmelsens punkt 1 eller 2. Den bör istället ske med stöd av PDL 2 kap. 4 § första stycke punkt 5. Den ändamålsbestämmelse som det bör hänvisas till i arbetet med högkostnad innebär således att det inte finns någon legal möjlighet att hantera uppgifterna med stöd av regler om sammanhållen journalföring.

Sammanfattningsvis i detta avsnitt kan konstateras att det finns flera var för sig gällande rättsliga hinder mot sammanhållen journalföring vid hantering av uppgifter om

³² PDL 6 kap. 1 §

³³ PDL 6 kap. 3 §

³⁴ Ytterligare ett alternativ är när uppgifter behövs i arbete med insatser för sjukskrivna.

högkostnadsskydd. Hantering av uppgifter kan ske genom utlämnande på medium för automatiserad behandling med ett fullt ut systembaserat/automatiserat beslutsfattande.

Stöd i OSL för utlämnande

För myndigheter inom hälso- och sjukvården gäller som huvudregel om sekretess för alla uppgifter om en individs hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.³⁵ Sekretesskyddade uppgifter är inte tillåtet att lämna ut eller på annat sätt röja om det inte finns stöd i lag.³⁶ Ett utlämnande av uppgift kan också ske med den berörda patientens medgivande eller efter en s.k. menprövning.³⁷ Uppgift om betald avgift och uppgift om avgiftsbefrielse är till sin karaktär uppgifter som alltid bör kunna lämnas ut till patienten själv. Bestämmelsen om sekretess i förhållande till patienten själv blir därmed inte tillämplig.³⁸ Följande sekretessbrytande bestämmelse är av intresse.

OSL 25 kap. 11 § punkt 5

Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas

...

5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en kommun eller en region till annan sådan myndighet för forskning eller framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs,

...

Uppgifter om betald avgift och om meddelad avgiftsbefrielse är uppgifter som behöver administreras för att hälso- och sjukvården i enlighet med HSL 17 kap. 6 § ska kunna fungera, dvs det är uppgifter för administration på verksamhetsområdet. Att den enskilde skulle lida men av att slippa behöva betala en avgift för hälso- och sjukvård är föga troligt. Regionerna får därmed med stöd av ovan sekretessbrytande bestämmelse lämna ut uppgifter om högkostnadsskydd till varandra. Informationsutbyte kan på det sättet ske med stöd av en nationell tjänst för högkostnadsskydd.

För privata vårdgivare gäller tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap. 12 §. Av bestämmelsen framgår att uppgifter inte får röjas obehörigen. Vid bedömningen av vad som är obehörigt röjande har lagstiftaren ansett att ledning kan sökas i bestämmelserna i OSL. Tanken är att tystnadsplikten i princip ska vara densamma för anställda i privat och offentlig regi.³⁹

³⁵ Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ("OSL") 25 kap. 11 § punkt 5

³⁶ OSL 8 kap. 1 §

³⁷ Dvs undantag som regleras i OSL

³⁸ OSL 25 kap. 6 §

³⁹ Prop. 1980/81:28 s. 23, prop. 1981/82:186 s. 26, samt prop. 1997/98:109 s 149-150

Sammanfattningsvis i detta avsnitt görs gällande att uppgiftsutlämnande i en nationell tjänst för högkostnadsskydd kan ske med stöd av OSL 25 kap. 11 § punkt 5.

Slutsatser

Utredande jurist har ombetts att utreda under vilket/vilka lagrum som information som omfattas av en nationell tjänst för högkostnadsskydd ska hanteras. I det följande anges de huvudsakliga lagrum och rättsliga stöd som enligt utredande jurists bedömning är tillämplbara för den aktuella tjänsten.

HSL 17 kap. 6 §

- Avgifter och avgiftsbegränsningar är frågor som regioner hanterar i sin roll som sjukvårdshuvudman.
- Regionerna måste i sin roll som sjukvårdshuvudman utföra efterregistreringar.
- Regionerna har ett nationellt och lagstadgat ansvar för högkostnadsskyddet.

EU:s dataskyddsförordning, art 7.1, art 9.1 och 9.2 (h)

- Uppgifterna som hanteras är personuppgifter.
- Uppgifterna är känsliga personuppgifter om hälsa.

PDL 1 kap. 1 § och 4 §

- Uppgifterna är sådana att PDL:s bestämmelser ska tillämpas.

PDL 2 kap. 2 §

- Uppgifterna får registreras utan patientens samtycke.

PDL 2 kap. 4 § första stycke punkt 5

- Uppgifter i en nationell tjänst för högkostnadsskydd hanteras med stöd av ändamålen administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten.
- En uppgiftshantering enligt bestämmelsen innebär att det inte är tillåtet att hantera uppgifterna med stöd av regler om sammanhållen journalföring.

HFD 2015 ref. 61

- Hantering av uppgifter kan ske genom utlämnande på medium för automatiserad behandling med ett fullt ut systembaserat/automatiserat beslutsfattande.

OSL 25 kap. 11 § punkt 5

- Utlämnandet av uppgifter kan ske med stöd av OSL 25 kap. 11 § punkt 5.

Bengt Guldager